Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?
Herzrasen?
Seit wann haben Sie Herzrasen?
Ist der Herzrasen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es einen bestimten Auslöser für den Herzrasen?
Ist er dauerhaft da, geht er wieder weg?
Wie lange dauert eine Attacke?
Haben Sie dabei Burstschmerzen, Lufnot oder Engegefühl?
Ist es das erstemal oder hatten Sie schon früher ahnliche Symptome?
Bauchschmerzen?
Wo genau haben Sie diese Schmerzen?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus?
Haben Sie Brustschmerzen, Luftnot oder ein Engegefühl?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es bestimmte Auslöser für die Schmerzen, z. B. Belastung oder nach dem Essen?
Hatten Sie in den Tagen bevor die Symptome eintreten vermehrt Stress oder irgendwelche Probleme?"
Was haben Sie gegessen?
Wo haben Sie das gegessen?
Gibt es jemanden, der das gleiche Essen gegessen hat und ähnliche Symptome hat?
Hat Ihre Frau auch ahnliche Beschwerde?
Sind die Schmerzen dauerhaft da, oder gehen sie wieder weg?
Ist es das erste Mal, oder hatten Sie schon früher ähnliche Symptome?
Waren Sie deswegen schon einmal bei Ihrem Hausarzt?
Wurde Ihnen Untersuchung durchgeführt?
Sind die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen stechend oder dumpf?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibt es etwas, das die Schmerzen verstärkt, z. B. Bewegung, oder etwas, das sie lindert, z. B. Hinlegen?
Haben Sie etwas gegen die Schmerzen genommen?

Wurden Sie schon einmal operiert?

Haben Sie Fieber?
Seit wann?
Haben Sie die Temperatur gemessen?
Wie hoch war sie?
Wo haben Sie gemessen?
Haben Sie Schüttelfrost?
Schwitzen Sie mehr als sonst oder haben Sie Schweißausbrüche bzw. Nachtschweiß?

Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
Seit wann?
Wie oft?
Wie sah das Erbrochene aus? Welche Farbe und Konsistenz hatte es?
Gab es Blut im Erbrochenen?

Haben Sie Probleme beim Stuhlgang?
Seit wann?
Wie oft?
Welche Farbe und Konsistenz hat der Stuhl?
Gibt es Blut im Stuhl?

Gibt es einen Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung?

Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?
Haben Sie Schmerzen oder Brennen beim Wasserlassen?
Welche Farbe hat der Urin?
Gibt es Blut im Urin?
Haben Sie verstärkten Durst bemerkt?
Wie viel Wasser trinken Sie täglich?

Haben Sie Völlegefühl oder Blähungen?

Leiden Sie unter Sodbrennen, saures Ausstoßen?

Wie ist Ihr Appetit?
Haben Sie in der lezten Zeit Gewicht abgenommen?

Können Sie wegen der Schmerzen schlecht schlafen?
Fühlen Sie sich müde?

Was essen Sie normalerweise? Essen Sie gerne Fleisch, Wurst, Sahne, Käse oder fetthaltige Speisen?

Gibt es andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten?

Am Ende des Gesprachs Aufklarung

Ich habe einen Verdacht **auf Reizmagensyndrome**. Das ist nicht schlimm und kann einfach mit Medikamenten behandelt werden. Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb brauche ich die Ergebnisse von Ihrer Magenspiegelung und dann sollen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.

Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen und einen EKG schreiben um eine Herzursache auszuschließen. Danach werde ich eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?
Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

EKG: Ein EKG ist eine schmerzfreie und Strahlenfreie Untersuchung. Es dauert nur 5 Minuten und wir legen Elektroden auf Ihre Brust und Ihre Gliedmaßen, um den Rhythmus Ihres Herzens zu registrieren. Sie müssen nur ruhig liegen bleiben.

Sonographie – Ultraschall:

Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet. Das ist nicht nur bei Schwanger, wir können damit alle inneren Organe beobachten.

Haben Sie an mich noch Fragen?

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen.
Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von **2,6 mmol/L** hat. Dieser Wert ist **deutlich erniedrigt** und entspricht einer **Hypokaliämie**.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.

Es geht um Herrn Tobias Becker. Er ist 36 Jahre alt, am 01.02.1984 geboren, 171 cm groß und wiegt 64,3 kg.

Er stellt sich bei uns wegen seit drei Tagen bestehender Bauchschmerzen im Oberbauch/Epigastrium vor.
Laut Angaben des Patienten sind die Schmerzen postprandial (nach dem Verzehr von Tofu mit Reis und Gemüse) aufgetreten.
Er berichtet, dass die Schmerzen nicht ausstrahlen und die Schmerzintensität bei 3/10 auf der Schmerzskala liegt.
Nach Angaben des Patienten sind die Schmerzen kolikartig und drückend.

Er erwähnt, dass er seit fünf Jahren ähnliche Beschwerden hat, die Schmerzen jedoch im Verlauf schlimmer geworden sind.
Er war vor drei Monaten bei seinem Hausarzt; ihm wurde eine ÖGD durchgeführt, ohne pathologischen Befund.
Er hat seit heute Morgen auch Tachykardie und ein Engegefühl in der Brust.

Begleitend klagt er seit drei Tagen über Nausea und seit heute Morgen über zweimaliges Erbrechen mit unverdautem Essen sowie seit gestern über Diarrhoe,

zwei- bis dreimal täglich, cremig, breiig, flüssig, dunkelbraun und explosiv. Außerdem hat er Konzentrationsstörungen, saures Aufstoßen und Völlegefühl.

Vegetativ-anamnestisch ergaben sich Inappetenz und schmerzbedingte Dyssomnie.

Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte er eine arterielle Hypertonie seit zwei Jahren, Fersenschmerzen und Clavus.
Er gab an, dass ihm im Alter von zehn Jahren eine Tonsillektomie durchgeführt wurde.

Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Nebivolol 2,5 mg (1-0-0) und Amlodipin 2,5 mg (1-0-0).

Bei der Allergienanamnese erwähnte er eine Allergie gegen Erdnüsse, die sich in brennendem Gefühl, Schweißausbrüchen, Pruritus, Parästhesien und Wärmegefühl im Mund äußert, sowie eine Allergie gegen Narkosemittel mit Erbrechen.
Er verträgt kein scharfes Essen.

Bei der Noxenanamnese erwähnte er lediglich zwei bis drei Gläser Alkohol (Schnaps, Bier, Weißwein, Rotwein, Rosé) abends, am Wochenende eher mehr.

Die Familienanamnese ergab arterielle Hypertonie, Glaukom, Vorhofflimmern und Myokardinfarkt beim Vater sowie Diabetes mellitus Typ II und Clavus bei der Mutter.
Eine Schwester leidet an psychosomatischen Magen-Darm-Beschwerden, die andere an arterieller Hypertonie.

Sozialanamnestisch ist er Kommunikationsdesigner von Beruf, verheiratet und hat eine Tochter.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein Reizdarmsyndrom hin. Die Bauchschmerzen ohne Ausstrahlung, Diarrhoe ohne Blut, der fehlende pathologische Befund in der ÖGD vor drei Monaten, Stress im Leben und Alkoholkonsum sprechen dafür.

Differentialdiagnostisch kommen GERD, chronische Gastritis, akute Gastroenteritis und Herzrhythmusstörungen in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.

Außerdem ist es wichtig, ein EKG zu schreiben, um Herzrhythmusstörungen auszuschließen.

Die körperliche Untersuchung ist wahrscheinlich unauffällig.

Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter (CRP, ggf. Procalcitonin/PCT), BZ, HbA1c, Elektrolyte, Herzenzyme (Troponin I/T, CK-MB), Nierenwerte und Leberwerte bestimmen lassen.

Anschließend werde ich das Ergebnis der ÖGD erfragen sowie eine pH-Metrie durchführen und ein Konsil in der Abteilung für Psychiatrie anfordern.

Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, empfehle ich folgende Therapie:

Der Patient wird ambulant behandelt.
Der Patient sollte eine symptomatische Behandlung erhalten, also Analgetika, Antiemetika und ggf. PPI oder Antazida.
Eine Alkoholkarenz wird verordnet. Eine Ernährungsumstellung wird empfohlen.
Anschließend werde ich ein Konsil in der Abteilung für Psychiatrie anfordern.

Reaktionen:

Ist Bluthochdruck erblich? Ist es wegen Stress? Reizdarm

Ja, Bluthochdruck könnte erblich bedingt sein. Wenn Ihre Mutter oder Ihr Vater an Bluthochdruck leiden, ist Ihr Risiko höher. Aber es gibt viele andere Risikofaktoren.

Ein gesunder Lebensstil, die Vermeidung von Stress und regelmäßige ärztliche Untersuchungen sind wichtig, um das Risiko zu verringern.

Was bedeutet chronische Erkrankungen? Reizdarm

Chronische Erkrankungen sind langfristige Gesundheitszustände, die kontinuierliche Behandlung erfordern.

Patientin hat am Anfang des Gesprächs gefragt, ob wir eine Magenspiegelung durchführen werden. Reizmagen

- Zuerst sollen wir unser Gespräch beenden. Es ist noch zu früh, um eine Entscheidung zu treffen. Ich kann auch die vorherigen Ergebnisse überprüfen.

- Ich verstehe Ihre Sorge, davon kann ich jetzt nicht ausgehen. Nach den Untersuchungsbefunden und der Rücksprache mit dem OA treffen wir die richtige Entscheidung. Aber ich würde sagen wahrscheinlich ist Magenspieglung bei Ihnen durchzuführen.

Am Ende:

- Wahrscheinlich ja, eine Magenspiegelung ist sehr hilfreich für die Diagnose. Aber zuerst machen wir die körperliche Untersuchung, das Labor und den Ultraschall. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht.

Er erzählte, dass er ständig Streit mit seiner Frau hatte und sie sagte, er sei ein Schluckspecht. Denken Sie auch an mich, dass ich Schluckspecht bin? Reizdarm

- Nein, Ich glaube nicht, dass Sie ein Alkoholiker sind.
- Aber ich muss fragen, wie viel Alkohol trinken sie täglich oder pro Woche?
- Es wäre besser, wenn Sie Alkoholkonsum reduzieren würden.

Schwester hat psychosomatische Beschwerden „Ihr Arm tut weh, keine Magenbeschwerden“ Wissen Sie, was es sein könnte? Reizdarm

?

Könnte es sich um psychosomatische Beschwerden handeln, sollten Sie einen Psychiater aufsuchen.

Als ich ihm sagte, dass ich ein Anamnesegespräch führen würde, sagte er "Gibt es andere Alternative dazu?" Reizmagensyndrom

Um Ihre Krankheit zu behandeln, muss ich alle wichtigen Informationen sammeln. Können wir anfangen?

Bekomme ich Krankschreibung? Reizmagen

- Heute können wir Ihnen eine Krankschreibung geben. Über die Fortsetzung (DAVAMI HAKKINDA)sprechen wir erneut nach den Ergebnissen.
- Natürlich werden Sie krankgeschrieben, also sind Sie hier, weil Sie krank sind, und ich tue mein Bestes, um Ihnen zu helfen.

Krankgeschrieben sein: istirahatli olmak

Was ist Tofu? Reizmagen

Tofu ist ein pflanzliches Lebensmittel aus Sojabohnen.

Warum muss ich Sport treiben, ich kann 2 Tablette einnehmen? Reizmagen - Anämie

- Regelmäßige Bewegung kann den Blutdruck senken.
- Sport verbessert die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die Durchblutung.
- Sport reduziert Stresshormone, die den Blutdruck erhöhen können.
- Ein gesunder Lebensstil kann die Wirksamkeit der Medikamente erhöhen.

Warum fragen Sie nach Drogen? ACS – Florian / Cholelithiasis / akutes Abdomen / OSAS / Reizdarm

- Diese Frage ist eine Routinefrage. Bitte nehmen Sie nicht persönlich. Drogen haben viele Nebenwirkungen. Deshalb muss ich fragen.
- Wenn Sie ja sagen, dann würden wir die Dosis Ihrer Medikamente anpassen.
- Wenn Sie eine Entzugstherapie benötigen, dann kann ich die anbieten.
- Machen Sie sich keine Sorgen, ich gebe Ihre Angaben nicht weiter. Das ist unsere Regel.

Was ist Glaukom-Grüner Star? ACS – Florian / Reizmagen

- Es ist eine Augenkrankheit und passiert öfter bei älteren Menschen. Es geht um einen erhöhten Augeninnendruck.

Hühnerauge: Wie kann man es vermeiden? Klavus. Reizmagen - ACS

- Um Clavus zu vermeiden, sollten Sie gut passende Schuhe aus atmungsaktiven Materialien tragen.

- Es gibt auch Lösungen außer der Operation, aber Sie sollten zuerst einen Orthopäden aufsuchen.

Dopplersonographie: vergrößerte Schilddrüse (Struma), vermehrte Vaskularisierung, Inhomogenitäten

Szintigraphie: erhöter Uptake von Isotopen (z.B. Technetium)

Psychosomatische Erkrankung sind körperliche Beschwerden, die durch seelische Belastung wie Stress, Angst oder Trauer ausgelöst oder verstärkt werden

6. Reizmagensyndrom s.43

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Spricht viel, erwähnt unnötige Infos Warum fragen Sie mich mein Personaldatum. Ich habe schon alle erwähnt.

A→ Ich frage zu nur um sicher zu sein

- Melanie / Tobias Beckers / Sven Schmidth
- 36 J.
- *01.02.1984
- 1,71 m
- 64,3 kg

-Hauptbeschwerde

Um Ihre Krankheit zu behandeln, muss ich alle wichtigen Information sammeln

- Gibt es eine Alternative dazu? Bunu bir alternatif var mı. Bunun başka bir yolu var mı?
- Etwas schlägt mir auf den Magen. Ich habe nervösen Magen.

Bir şey midemi oturdu. Bir şey beni çok üzdü Midem sıkıntıyı

- Tachykardie (Herzrasen)
  - Seit heute Morgen
  - Mit Palpitation (Herzklopfen) und Angina pectoris (Engegefühl im Brust)
    - Woher kommt Herzrasen? Ich habe angst
      - Momentan kann ich Ihnen nicht antworten, es kann mehrere mögliche Ursachen geben, von denen viele nicht schlimm sind.
      - Lassen Sie uns die Gespräche weiterführen und ich werde Ihnen am Ende sagen, was ich vermute.
    - Bekomme ich Krankschreibung? (3 Mal) Ich muss ~~zuerst~~ erstmal wissen, was Sie haben.
      - Es hängt von den Ergebnissen der Untersuchungen ab. Auf jeden Fall lasse ich Sie nicht krank zur Arbeit gehen.
- Abdominalschmerzen (Bauchschmerzen)
  - Epigastrium, keine Ausstrahlung
  - Seit 3 Tagen
  - plötzlich
  - persistierend
  - Postprandial/ bewegungsabhängig: nach Verzehr von Tofu (mit Reis und Gemüse) im Thai-Restaurant.
    - Meine Frau hat mich gezwungen, im Thai-Restaurant zu gehen.
    - Was haben Sie dort gegessen?
  - Drückend, kolikartig
  - Bei 3/10 (postprandial stärker)
  - Ähnliche Symptome, seit 5/10 J., rezidivierend, früher 1-2/10, progressiv
  - Vor 3 Monaten ÖGD bei HA o.p.B.
    - Werden Sie die Magenspiegelung wiederholen?
    - Denken Sie, dass bei der letzten Magenspiegelung etwas übersehen wurde? gözden kaçmış
    - Ich werde mich an Ihren Hausarzt wenden, um die Ergebnisse zu erhalten, und wir werden sehen, ob wir es wiederholen sollen oder nicht.
- Nausea (Übelkeit) seit 3 Tagen

- Emesis (Erbrechen) 2 Mal heute Morgen (unverdautes Essen): Danach habe ich mich besser gefühlt.
- Diarrhö (Durchfall)
  - Seit gestern
  - 2-3 Mal/d
  - Cremig, breiig, flüssig, dunkelbraun/braun, explosiv
  - Letztes Mal: heute Morgen
  - Ohne Blut
- Konzentrationsstörung
- Saures Aufstoßen
- Völlegefühl
- Herzrasen: Wann tritt es auf? Wie oft? Brustschmerzen? Atemnot?
- Gibt es einen Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung? oder haben Sie immer Durchfall?

-vegetative Symptomatik

- Inappetenz, scharfes Essen
- Schmerzbedingte Insomnie
- Fersenschmerzen: ~~Wissen Sie, wo Fersen sind? Könnten Sie bitte es nachsehen? Ist es etwas Schlimmes? Soll es operiert werden?~~ bazna z
  - Ich werde das während der körperlichen Untersuchung überprüfen. Bitte machen Sie sich keine Sorge. Ich verstehe, dass Sie Angst haben. Bestimmen Sie bitte

Beim Zusammenfassen: ~~sagen Sie mir lieber, was Sie machen?~~ Ich werde Ihnen alles erklären am Ende des Gesprächs

-gyn: *Melanie Becker*

- Letzte Menstruation: vor 2 W.
- Menarche: 11 LJ
- 1 Schwangerschaft
- Keine Verhütungsmittel (Ehemann vasektomiert)

-Vorerkrankungen

- ~~Was sind chronische Erkrankungen?~~ Zum Beispiel Bluthochdruck, Zuckerkrankheit? langfristige Gesundheitszustände, die kontinuierliche Behandlung erfordern
- aHT seit 2 J. letzte Kontrolle: vor 3 T, 130/80
  - ~~Ist Bluthochdruck erblich?~~ Ja, das kann es ~~eine erbliche~~ Komponente geben. Es kann aber auch mit Ihren Gewohnheiten verbunden. das kann erblich sein
  - ~~Ist es wegen Stress?~~ Stress hilft nicht auf jeden Fall, aber es geht in der Regel nicht nur darum. Natürlich, Stress kann Ursache sein
- Clavus (Hühnerauge)
  - ~~Wie kann man es vermeiden?~~ Sie können einfach mit Ihrem Hausarzt über das sprechen. Man kann es vermeiden, indem man bequeme Schuhe trägt. Die Hühnerauge entsteht unter dem Druck.

-Vor-OPs

- TE mit 10. LJ (PONV): ~~Nach dem OP habe ich viel geschlafen und hatte ich Übelkeit und musste ich mich übergeben.~~
  - Ja das kann passieren, das gehört zu den Nebenwirkungen von Betäubungsmitteln. Es ist gut, dass Sie es erwähnt haben, ich werde es in Ihre Akte aufnehmen und wir können Ihnen Medikamente gegen die Nebenwirkungen geben.

-Medikation

- Nebivolol 2,5 mg 1-0-0 p.o.
- Amlodipin 2,5 mg 1-0-0 p.o.
- ~~Warum muss ich Sport treiben, ich kann 2 Tablette einnehmen?~~

Die Tabletten sind kein Ersatz für Sport, das wäre zu einfach. Nehmen Sie niemals eine doppelte Dosis ohne ärztlichen Rat ein. Sie könnten einen niedrigen Blutdruck bekommen und sich schlechter fühlen.

3

-Allergien

- Erdnussallergie (brennendes Gefühl, Hyperhidrose, Pruritus, Parästhesie und Wärmegefühl im Mund)
- Narkoseintolerenz (Vomitus)
- Scharfes Essen (BS, Diarrhö, Vomitus)

-Noxen

Ich habe keine Lungenprobleme. Warum fragen Sie nach dem Rauchen?

- Nikotin: Nichtraucher — Ich frage, weil Raucher viele Krankheiten bekommen können, nicht nur die Lunge
- Alkohol: 2-3 Gl. Schnaps, Bier, Weißwein, Rotwein, Rose abends, mehr am WE
  - Meine Frau beschwert sich immer über mich. Sie sagt, dass ich Schluckspecht bin. Denken Sie auch so? Wissen Sie, was das heißt?
  - Ja das ist ein umgangssprachlicher Begriff für Alkoholiker. Aus medizinischer Sicht ist Alkohol täglich zu viel. Haben Sie versucht mit dem Alkohol aufzuhören?
  - Das ist doch nicht viel, die Gläser sind sehr klein
  - Dies könnte der Grund für Ihre Magenbeschwerden sein. Sie sollten damit aufhören. Ich kann Ihnen einen Spezialisten empfehlen, wenn Sie Unterstützung beim Aufhören benötigen.
- Drogen: keine
  - Sehe ich so aus? — Nein. Natürlich nicht.
  - Nein das ist nur um ~~Sie~~ Aber so gut wie möglich zu behandeln. Drogen können Nebenwirkungen und Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten haben.

-Sozialanamnese

- Kommunikationsdesigner (Vollzeit, zufrieden)
- Verheiratet, lebe mit Ehemann/-frau zusammen, streit
  - Ehefrau: Rechtsanwältin
  - Ehemann: Finanzbeamter
- 1 Tochter (6 J.)
- Reise: vor ein paar Monaten an der Nordseeküste
- Impfung: vollständig

Es ist eine Augenkrankheit, und passiert öfter bei älteren Menschen. Es geht um einen erhöhten Augeninnendruck. Die Therapien des Glaukoms besteht zunächst aus Augentropfen zur Senkung des Augeninnendrucks, wenn diese nicht ausreichen, kann eine Laser oder operative Behandlung notwendig sein.

-Familienanamnese

- Vater (70): aHT, Glaukom, VHF (HRST), Z.n. MI (mit 63. LJ)
  - Mein Vater hat grünen Star. Was ist das? Ist es erblich? Muss er operiert werden? Ist es etwas Schlimmes? Ist es gefährlich? Was ist genetische Prädisposition? Gibt es noch andere Stars? Welcher ist gefährlich? → Es gibt auch Grüne Star. Das ist nicht einfach zu sagen, welcher gefährlich ist. Es hängt von vielen Faktoren ab.
  - Grüner Star ist eine Erkrankung des Sehnervs, es ist häufig mit einem erhöhten Augendruck verbunden. Es kann eine erbliche Komponente vorliegen, aber nicht immer. Es hängt meist mit anderen Krankheiten zusammen, wie Bluthochdruck, Zucker oder der Einnahme von Kortison.
  - Konzentrieren wir uns bitte auf Ihre Geschichte.

Ich bin keine Augenärztin. Ich empfehle Ihnen einen Augenarzt aufzusuchen, um das genauer abklären zu lassen.

- Mutter (76): DM T2 seit 3 J., Clavus (Hühnerauge)
  - Ist er erblich? — es entsteht unter ~~dem~~ dem Druck.
    - Nein es ist nicht erblich, es hängt von der Hygiene Ihrer Füße ab. Ich ~~lasse~~ empfehle Ihnen, einem Podologen zu besuchen, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.
- Schwester: psychosomatische Magen und Darmbeschwerden, Schmerzen an den Armen und Beinen
  - Wissen Sie, was psychosomatisch bedeutet?
    - Keine organische Ursache gefunden

- Die Ärzte konnten nichts finden, könnte es Krebs sein?
  - Auf jeden fall nein, Krebs ist eine organische Ursache.
- Schwester: aHT (Bluthochdruck)
- Tochter: Clavus (Hühnerauge)

Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht ~~auf Reizmagensyndrome~~. Das ist nicht schlimm und kann einfach mit Medikamenten behandelt werden. → Entzündung der Magenschleimhaut (oder) Reizung der ~~im Magen~~ ~~oder Darm~~ Magenschleimhaut und des Darms
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb brauche ich die Ergebnisse von Ihrer Magenspiegelung und dann sollen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst Ihren Körper untersuchen, dann werde ich Ihnen Blut abnehmen. Und wir werden einen EKG durchführen. Wissen Sie was das ist?
EKG: Ein EKG ist eine schmerzfreie und Strahlenfreie Untersuchung. Es dauert nur 5 Minuten und wir legen Elektroden auf Ihre Brust und Ihre Gliedmaßen, um den Rhythmus Ihres Herzens zu registrieren. Sie müssen nur ruhig liegen bleiben.

-Fragen → Ihre Befunde passen nicht zu einem Krebs.

Ich habe Angst, dass ich Krebs habe? Was habe ich? Was ist die Ursache dafür? Bin ich mir sicher, dass es kein Krebs ist. Sie zeigen keine Symptome.
Warum EKG? Denken Sie an Herzschlag? Nein, das ist nur, um sicherzugehen, dass Sie keine Rhythmusstörungen haben, da Sie ein Gefühl von Herzrasen haben.
Was machen Sie jetzt? Welche Therapie? Wir machen jetzt erst einmal die Untersuchungen und dann komme ich wieder zu Ihnen und erkläre Ihnen die Therapie.
Soll ich im KH bleiben? Ich muss ein paar Sachen bringen. Nein ich glaube das ist nicht notwendig
Muss ich in die Röhre? Ja
Ich habe keine Zeit, ich muss nach Hause. Wenn Sie nach Hause zurückkehren möchten, müssen Sie dieses Formular ausfüllen.
Ist es eine neue Krankheit? Es handelt sich um eine psychosomatische Krankheit, die diagnostiziert wird, nachdem alle organischen Ursachen eliminiert wurden.

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Notaufnahme.

Es geht um **Herr Tobias Becker, 36** Jahre alt, der in gutem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Er beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit heute Morgen Tachykardie mit Engegefühl in der Brust. Seit 3 Tagen, epigastrische Schmerzen, die persistierende, progrediente, drückende, kolikartige sind und insbesondere post-Prandial (nach dem Verzehr von Tofu in einem Taï-Restaurant). 3 von 10 auf einer Schmerzskala.

Begleitend ist Nausea, Emesis (2 Mal heute Morgen mit Essensreste), seit 3 Tagen explosive Diarrhö 3-4 Mal pro Tag, Saures Aufstoßen (Ructus), Völlegefühl und Konzentrationsstörung.

Er war vor 3 Monaten für diese Beschwerden bei seinem HA, der eine ÖGD durchgeführt hat, ohne pathologischen Befund.

Er hat keine Fieber, aber Inappetenz und Schmerzbedingte Insomnie. **Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.**

Er leidet an aHT seit 2 J. und nimmt regelmäßig dagegen Nebivolol und Amlodipin.

Er hat Erdnussallergie, Narkoseintolerenz und scharfes Essenintolerenz.

In der Familie, es gibt VHF, MI und DMII.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf funktionelle Dyspepsie. An Differentialdiagnosen sind zu nennen GERD, akute Gastritis, und ~~Herzrhythmusstörungen~~.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, Entzündungsparameter, E-lyte, Leber-Nierenwerte, Glukose, Herzenzyme. Auch ein Langzeit-EKG, um die HRST zu vermeiden und ich werde das Ergebnis der ÖGD fragen. Ich würde auch ein pH-metrie durchführen. Ggf. ein psychiatrische Konsil anzufordern.

Als Therapie schlage ich initial/symptomatisch: Antiemetika, Analgetika, Antidiarrhoika, ggf. PPI und Antazida

Bei kausal empfehle ich Umstellung der Ernährungsgewohnheiten

Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen

Was ist ein Bäcker? Er stellt Brot

Warum ist diese Info wichtig? Um den BMI zu bestimmen

Wann tritt das Herzrasen auf? Wie häufig tritt es auf? Brustschmerzen? Engegefühl? Dyspeptische Beschwerden

Würden Sie ihm einen Geldschein/AU geben? Nein, denn er scheint nur deswegen gekommen zu sein.

Wo hat der Pat. das Essen verzehrt? Was ist Tofu? Tofu ist eine Sojabohnenpaste.

Was könnte ein Thai-Restaurant sein? Ein Restaurant, in dem thailändische Spezialitäten serviert werden

Warum ist es uns wichtig zu wissen, was für ein Essen es war? Scharf oder fettig? Der Pat. verträgt kein scharfes Essen

Welche Typen von Schmerzen waren sie? Psychosomatische Schmerzen / Sodbrennen

Wie können Sie die Gastroskopie-Ergebnisse finden? Ich kann sein HA anrufen, um die Ergebnisse zu fragen.

Ist cremiger Stuhl wie Wasser? Nein, cremiger Stuhl ist nicht wie Wasser. Es hat flüssigere Konsistenz als normaler Stuhl, ist aber nicht vollständig wässrig. Er ist eher pastös und oft verursacht durch Ernährungsumstellungen (Ballaststoffenmangel oder zu viel Fett in der Ernährung)

Wie misst man den BD und wie berichtet man ihn?

- Zur Blutdruckmessung wird die Manschette um den unbekleideten, gestreckten Oberarm gelegt und dann so stark aufgepumpt, dass kein Blut mehr in die Oberarmarterie fließt.
- Als Blutdruck wird der Druck in den Arterien des Körperkreislaufs bezeichnet. Er schwankt bei jedem Herzschlag zwischen einem Maximalwert, dem systolischer Wert und einem Minimalwert, dem diastolischer Wert.
- Man berichtet ihn, indem man den Wert des systolischen Drucks "zu" den diastolischen Druck in Millimeter Quecksilber notiert.

Wie schreibt man Nebivolol? Welche B-Blocker kennen Sie? Propranolol, Metoprolol, Atenolol, Bisoprolol, Carvedilol

Was bedeutet Narkose? Medikamentös-bedingter Schlafzustand (= Allgemeinanästhesie), eine medikamentös induzierte, steuerbare Bewusstlosigkeit

Warum braucht man ein BTM-Rezept? Wegen Drogenabhängigkeit und Nebenwirkungen

Ist Aspirin ein Narkosemittel? (= Acetylsalicylsäure) Nein, es ist einen nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR)

Ein Beispiel für Narkosemittel? Fentanyl, Propofol

Ist der Pat. Alkoholiker? Warum trinkt er abends? Ja, Alkoholismus wird durch das Auftreten von mindestens drei Kriterien definiert:

- Craving (Zwangsstörung)
- Kontrollverlust
- Tolerenzentwicklung
- Konsum zu unpassenden Zeiten / Konsum ohne Rücksicht auf soziale Auswirkungen

Was bedeutet, dass der Pat. spinnt/schwindelt? Lügt. **Was bedeutet Schluckspecht?** Alkoholiker. **Trinkt der Pat. zu viel? Wie viel trinkt er/sie? Weinalkoholinhalt?** 15%

Was ist grüner Star? Das Glaukom (= grüner Star) ist eine degenerative Erkrankung des Sehnervs, die zu einem fortschreitenden Verlust des Sehvermögens von der Peripherie zum Zentrum hinführt. Es ist häufig mit einem erhöhten Augendruck verbunden

Welche anderen Stare gibt es noch?

- Die Katarakt (= Grauer Star) ist eine Trübung der Augenlinse
- Das Leukom (= Weißer Star) Korneada bulut lekesi
- Die Amaurose (= Schwarzer Star) Tam körlüğü

Was ist ein grauer Star? Was passiert bei Katarakt? Ist eine Trübung der Augenlinse

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er DM hat? 50%

Was bedeutet Kommunikationsdesigner? Ein Kommunikationsdesigner nutzt visuelle Mittel, um Informationen und Botschaften effektiv zu vermitteln und arbeitet dabei in Bereichen wie Grafikdesign, digitale Medien, Werbung und Branding.

Hat der Pat. Stress? Warum hat er Stress? Welchen Beruf übt die Frau aus?

Unterschied zwischen Rechtsanwältin und Staatsanwältin?

- Der Rechtsanwalt ist der berufene unabhängige Berater und Vertreter in allen Rechtsangelegenheiten. Er übt einen freien Beruf aus und vertritt die Interessen des Mandanten.
- Der Staatsanwalt hingegen ist Beamter und weisungsgebunden. Er ist Teil der Behörde, die für die Strafverfolgung und Strafvollstreckung zuständig ist. Er vertritt damit die Interessen des Staates hinsichtlich der Verfolgung von Straftaten.

Wie ist die Ehebeziehung des Pat.? Ist die Frau gut mit ihm? Was hat er über seine Frau gesagt? Seit wann ist er verheiratet? / Hat er starke Persönlichkeit? Nicht so gut

Begründen, Was spricht dafür? Reizmagensyndrom: eine funktionelle Störung, die ähnlich wie das Reizdarmsyndrom mit einer erhöhten Schmerzempfindlichkeit gegenüber Dehnungsreizen und mit Somatisierungsstörungen einhergeht.

Warum EKG? Gibt es RF? Ja Familiengeschichte und aHT

Was erwarten Sie bei KU? Ich werde Tachypnö, Tachykardie, Hautturgor, BD, akutes Abdomen suchen

Wie untersucht man den Bauch? Was erwarten Sie bei Darmgeräuschen? Meteorismus (erhöhte Darmgeräusche)

Sollte der Pat. ein Papier unterschreiben für die Blutabnahme? Normalerweise nein, das ist Teil der Behandlung

Was sind Cholestaseparameter? Gamma-GT, alkalische Phosphatase und Bilirubin

(7)

Laborwerte: erhöhte GOT und GPT => zu viel Alkohol, alkoholische Fettleber, Hepatomegalie

Troponin ist nicht durchgeführt, was machen Sie? Labor anrufen und nachmelden

Nehmen Sie den Pat. auf? Warum? Nein, wenn die Ergebnisse des Bluttests normal sind, empfehle ich ihm, sich und seine Frau von einem Psychologen beraten zu lassen, und verschreibe ihm eine symptomatische Behandlung.

Braucht der Pat. palliative Therapie? Warum? Ist die Krankheit heilbar? Wer bekommt palliative Therapie? Krankheiten, die nicht geheilt werden können oder deren Ursache nicht bekannt ist.

Was ist der Unterschied zwischen Ulcus ventriculi und duodeni?

- Patienten mit Ulcus duodeni berichten häufig, dass der Schmerz in Nüchternphasen auftritt und sich nach Nahrungsaufnahme bessert.
- Patienten mit Ulcus ventriculi klagen häufig über nahrungsabhängige Schmerzen.

Die Ursache für Ulcus? ***(= Geschwür)*** (Magengeschwür)

- Chronischer Helicobacter pylori-Gastritis.
- Einnahme von NSAR = nicht steroidale Antirheumatikum
- Akuter Stress

PPI in Pankreatitis? Ja, zur Stressulkusprophylaxe

Wie können wir die Säure im Magen messen? pH-Metrie

Was bedeutet BZ: 120 mg/dl? Was ist mg/dl? Wenn es sich um einen Nüchternwert handelt, ist es eine Hyperglykämie (Oraler Glukosetoleranztest / OGTT durchzuführen). Es ist eine Maßeinheit.
Glucosuria

Was sind die Grunduntersuchungen im KH? KU, Labor, EKG (ggf. Sonographie, CT, MRT)

Gibt es Tumoren, die immer bösartig sind? Lymphome, Melanom

Was ist ein Rezept? An wen wird es geschrieben? Ein Rezept ist eine Arzneiverordnung und wird an Patienten geschrieben
Non recetesi

Was ist der Unterschied zwischen GKV und PKV?

- Gesetzliche Krankenversicherung: es ist das allgemeine System für alle
- Private Krankenversicherung: Kostenerstattungsprinzip, für jemand der mehr als 66.000€ pro Jahr bekommt.
Mesrof gai Edune prensip.

Was ist Triage? Unter Triage bzw. Sichtung werden in der Notfall- bzw. Katastrophenmedizin Verfahren verstanden, die im Fall eines Massenanfalls von Verletzten bzw. Erkrankten MANV eine schnelle und orientierende Einteilung der Betroffenen in unterschiedlich priorisierte Kategorien zulässt.
Triaj Afet tıb yaralı

ABCD-Schema im Notfall? Die Sichtung erfolgt nach Dringlichkeit

- A - Airway (Atemweg)
- B - Breathing (Beatmung)
- C - Circulation (Kreislauf)
- D - Disability (Defizit, neurologisches)
- E - Exposure/Environment (Exploration)

Massenanfalls von Verletzten
MANV
Toplu yaralı olayı

Gürdür-sacum 2.15 bakıyorum tesaretiniz

Unterschied zwischen Verbeugen/Vorbeugen?

- Verbeugen: nach vorne beugen
- Vorbeugen: um etwas zu verhindern

Warum nach dem Krieg weniger DM? Viel Arbeit

Was bedeutet astrein? Frei von Ästen, einwandfrei, ohne Fehler oder Perfekt
hünza

Der Pat. kann nicht im KH Alkohol trinken, die Schwester sagt, er ist unruhig, warum? Was ist das genannt? Entzugssymptome, Alkoholismus (Craving und Kontrollverlust)

(8)

Utopsi

Der Pathologe macht Obduktion, was bedeutet das? Autopsie / die Eröffnung eines menschlichen Leichnams zur Feststellung der Todesursachen.

Cesch

Was bedeutet: Die Frau trägt die Hose zu Hause? Sie hat die Kontrolle und macht alle Entscheidungen

Wo können Krampfadern auftreten? = Varize: Ösophagus, Beine, Hoden, Caput medusa

Mediosar

Was ist Berufshaftpflichtversicherung? sichert Personen- und Sachschäden sowie deren finanzielle Folgen ab. Für einige Selbstständige in freien Berufen ist sie eine Pflichtversicherung, bspw. für Ärzte oder Hebammen.

Die Berufshaftpflichtversicherung ist eine gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung für bestimmte Berufe, z.B. Ärzte oder Anwälte. Sie deckt Schäden ab, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit entstehen können.

TVT: Diagnose, Behandlung

- Diagnose: klinischen Untersuchung mit Homans-Zeichen, Payr-Zeichen, Meyer-Zeichen, Lowenberg-Zeichen. D-Dimer und Duplex-Sonographie / Phlebographie.
- Behandlung: zuerst niedermolekulare Heparin (NMH), dann Vitamin-K-Antagonisten (Phenprocoumon) oder direkte orale Antikoagulanzien (Rivaroxaban) und Kompressionstherapie mit Kompressionsverband.

Homans Zeichen → Schmerzen in der Wade bei forcierter Dorsalflexion des Fußes

Arten von Star:

- Grauer Star: Katarakt
- Grüner Star: Glaukom
- Schwarzer Star: Amaurose
- Weißer Star: Leukom

Payr Zeichen → Schmerzen an der medialen Fußsohle oder Wade bei Druck auf die mediale Fußseite

Lowenberg ~~Meyer~~ Zeichen → Stauze Wadenschmerzen, wenn eine Blutdruckmanschette am Unterschenkel auf 80-100 mmHg aufgepumpt wird

Narkosemittel-Beispiel? Alfentanil, fentanyl, Halothan, Enfluran, Isofluran, Ketamin, Etomidat, Propofol

Was bedeutet der Pat. spinnt? Der Patient ist verrückt

Meyer Zeichen → Wadenschmerzen bei anterior-posterior Kompression des Unterschenkels

Was ist Zangengeburt? Schwere Geburt mit Forceps

Sonographie-befunde bei ASH (= Alkoholische Steatohepatitis)? Hepatomegalie, leicht hyperechogenem Parenchym und abgerundetem Unterrand

Vergrößert

MCV erhöht, Ursache? Megaloblastäre Anämie = B12- und Folsäuremangel.

Einheit von RR? Was ist Quecksilber? Millimeter Quecksilber, es ist ein chemisches Element (von altgriechisch: hydrargyrum)

Was ist exokrine Pankreasinsuffizienz? Verminderten oder gar fehlenden Enzymsekretion. Insbesondere durch den Mangel an Lipase kommt es zur Maldigestion und Malabsorption von Fetten.

Wie hoch ist der Anteil der psychosomatischen Erkrankungen? Warum? Jedes Jahr sind 28% der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Die Menschen werden immer gestresster ich denke.

Open-Window-Phänomen? die erhöhte Infektanfälligkeit eines Organismus nach psychischen oder physischen Belastungsphasen. Durch immunologische Veränderungen steigt dabei u.a. die Wahrscheinlichkeit für eine Erkältung oder auch eine Harnwegsinfektion.

MCV-Einheit: fl (Femtoliter), RB: 83 bis 97 fl

Ab welchem Bilirubin-Wert ist Ikterus sichtbar? Ab 2 mg/dl (zwischen 1 und 2 mg/dl: Subikterus)

Woher kommt der Name Apgar? Maximal wert? im Jahr 1953 von der New Yorker Chirurgin und Narkoseärztin Dr. Virginia Apgar. 10 (> 7 ist gut nach 1 Minute)

ADGAR – A → Atmung
P → Puls
G → Grundtonus
A → Aussehen (Hautfarbe)

postnatalen Adaptation eines Neugeborenen nach 1, 5 und 10 Minuten:

- Aussehen (Hautfarbe)
- Puls (Herzaktion)
- Gesichtsbewegungen (Grimmassieren), auch: Grundtonus (Muskeltonus)
- Aktivität
- Respiration

Essenzielle arterielle Hypertonie, wie viel Prozent? 85% aller Hypertonie-Fälle.

Wer ist Achilles? Achilles ist eine Figur aus der griechischen Mythologie und der wichtigste Held des Trojanischen Krieges (die Achillessehne (Tendo calcaneus oder Tendo Achillis))

Was bedeutet „Reiz"? = Stimulus. Im neurobiologischen Sinn ein Ereignis, das zur Erregung (Stimulation) einer Wahrnehmungsstruktur (Rezeptor) führt.

7. Lymphom-Hodgkin s.52

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

- Henri Fechner
- 68 / 73 J.
- 01.03.1954
- 1,68 m
- ? Weiß ich nicht, meine Waage ist kaputt.

-Hauptbeschwerde

- Gewichtsverlust
  - 3-4 kg innerhalb 2 Mo.
- Lymphadenopathie (Schwellung)
  - Seit 2 / 6 Mo.
  - Schmerzlos
  - Am Hals
  - Halsumfang erhöht (Kragenweite erhöht): mein Halsumfang ist vergrößert, es ist, als ob alles geschwollen wäre. Meine Frau hat mir eine Kette/ein Schmuckstück geschenkt, das ich nicht mehr tragen kann.
- Hat er/sie sich vergrößert?
- Tut es weh beim Tasten?
- Ist/Sind es/sie weich oder hart?
- Können sie den/die verschieben oder ist der/die fest?
- Schwellung an anderen Orten?
- Fieber (undulierendes Fieber) und Schüttelfrost
  - 39
  - Täglich: ich messe die Temperatur regelmäßig und manchmal ist es 37°, manchmal 39°. Es kommt und geht von selbst
    - Wo haben Sie sie gemessen?
- Asthenie und Adynamie: ich fühle mich ganz schwach, ich habe keine Energie mehr für nichts. Ich bin ständig müde, selbst wenn ich gut geschlafen habe.
- Husten: Trockene oder mit Auswurf? Haben Sie Luftnot?
  - Tagesüber
  - Trocken: es ist, als ob mir etwas im Hals stecken bleibt / kratzen
- ~~Thoraxschmerzen / Bauchschmerzen / Dyspnö~~

Patient Lin

Cornelius von Hohenstieg
39 J.
* 21.01.1986
1.84 m 89.9 kg

RDS

Hauptbeschwerde

- seit heute Morgen bestehende, plötzlich aufgetretene, persistierende Tachykardie mit Engegefühl
- seit 3 Tagen bestehende, plötzlich aufgetretene, persistierende, drückende, koliartige Bauchschmerzen im ganzen Bauch.
- Auslöser: Verzehr von Tofu mit Reis und Gemüse
- die Schmerzintensität: 4/10 auf der NRS
- ohne Ausstrahlung verstärkende Faktoren: Bewegung
- ähnliche Beschwerden: seit 5 Jahren, rezidivierend, progredient, vor 3 Monaten beim Hausarzt, ÖGD: o.p.B
  ↳ (ohne pathologischen Befund)

Begleitsymptome

- Übelkeit
- Erbrechen (2 Mal, heute Morgen, unverdautes Essen, ohne Blut)
- Diarrhoe (2-3 Mal, seit gestern, cremig, breiig, wässrig, explosiv, dunkler Braun, ohne Blut)

Vegetative Anamnese

- Inappetenz
- Dyssomnie

Vorerkrankungen

- aHT seit 2 Jahren (letzte Messung: 130-80 mmHg)
- Clavus

OP:

- Tonsillektomie mit 10. Lj. (PONV) (Postoperative Nausea und Vomitus)

Medikamente

- Nebivolol 2,5 mg (1-0-0)
- Amlodipin 2,5 mg (1-0-0)

Allergie / Unverträglichkeit

Allergie (orale ~~allergische~~ Symptom)

Erdnuss (Pruritus, Kribbeln, brennendes Gefühl, Wärmegefühl im Mund)
Milchzuckerintoleranz (Übelkeit, Erbrechen, Schlafen)

Genussmittel

Alkohol: ✓

Familienanamnese

Vater: aHT, Glaukom, VHF, 2n. MI vor 7 Jahren
Mutter: DM Typ II, Claudicatio
Schwester: aHT
Schwester: Psychosomatische Beschwerden

Sozialanamnese

Kommunikationsdesigner
verheiratet
eine Tochter (gesund, 6 Jahre alt)
Stress im Privatleben

Verdachtsdiagnose

Reizdarmsyndrom (RDS)

Differentialdiagnose

- Nahrungsempfindlichkeit
- Gastritis
- akute Gastroenteritis

weitere Procedere

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: BB, Entzündungsparameter, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte, Stuhldiagnostik
  Stuhluntersuchung
- Sonographie - Abdomen
- gastroenterologisches Konsil
- psychologisches Konsil psychiatrisches Konsil

Therapie

- ambulante Behandlung
- Antianalgetika
- Antiemetika
- Antidiarrhoika ggf. PPI oder Antibiotika
- Patientenschulung (Stressbewältigung)
  Alkoholzarenz
- ggf. Paar Therapie

① Wie oft bekommen Sie diese Beschwerde pro Woche?

② Haben Sie immer Durchfall oder Gibt es ein Wechsel zwischen Durchfall oder Obstipation

ROMA-IV Kriterien

Hauptkriterien

- Wiederkehrende Bauchschmerzen, mindestens 1 Tag pro Woche in den letzten 3 Monaten
- Beginn der Beschwerden vor mindestens 6 Monaten

+ Zusätzlich mindestens 2 der folgenden Kriterien

① Zusammenhang mit der Defäkation
(Besserung oder Verschlechterung nach dem Stuhlgang)

② Veränderung der Stuhlfrequenz

③ Veränderung der Stuhlkonsistenz

Subtypen nach ROMEIV

RDS-D → Diarrhoe
RDS-C → Obstipation
RDS-M → Gemischte Typ
RDS-U → Nicht klassifizierbar

RDS → ist eine Ausschluss Diagnose

Vor der Diagnose müssen Alarmzeichen (Red flag) ausgeschlossen werden

Gewichtsverlust
Anämie
Blut im Stuhl
nächtliche Symptome
positive Familienanamnese für Kolorektalkarzinom oder CED

Hühneraugen → Hornhautknoten

↓
Das ist eine schmerzhafter Hornhautknoten durch Druck, zum Beispiel durch enge Schuhe.

Fersensporn → Ein Fersensporn ist ein knöcherner Auswuchs (Zahn) an der Ferse und entsteht durch Überbelastung

Der Fersensporn kommt vom Knochen, das Hühnerauge von der Haut

Fettleber → Eine Fettleber (steatosis hepatis) liegt vor, wenn sich zu viel Fett in den Leberzellen ansammelt.

① Alkoholischer Fettleber (AFLD)
(reversible)

② Nicht alkoholische Fettleber (NAFLD)

③ Fortgeschrittene Stadien
fibrose → Leberzirrhose

Wann sollte eine ÖGD erneut durchgeführt werden?

Alarmzeichen

Neu aufgetretene oder zunehmende Beschwerden

Gewichtsverlust

Anämie

Blutungszeichen (Hämatemesis, Melöna)

Dysphagie oder Odynophagie

nächtliche Schmerzen